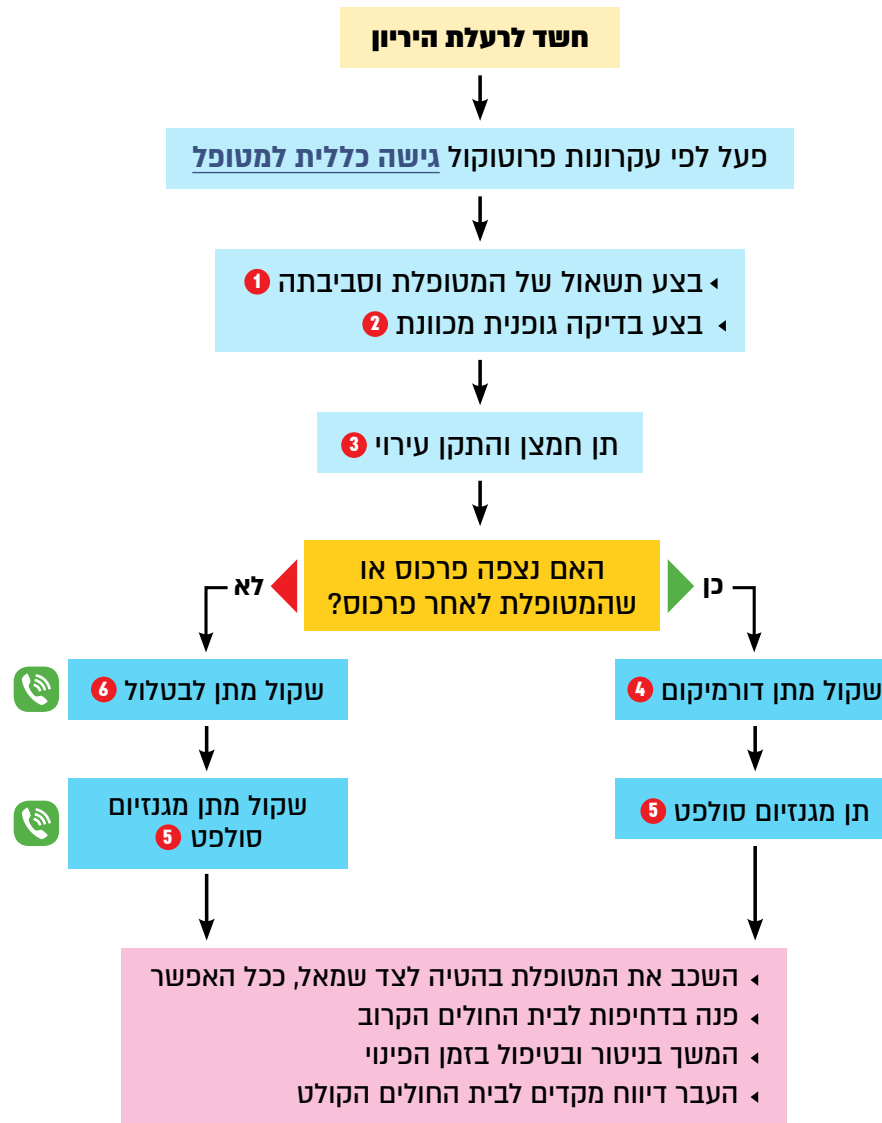




## 1 תשאול המטופלת וסביבתה

- + גיל ההיריון –
- משבוע 20 להיריון עד חודשיים לאחר הלידה.
- + גורמי סיכון –
- היסטוריה אישית או משפחתית.
- היריון ראשון.
- היריון מרובה עוברים.
- מטופלת מעל גיל 40.
- מחלות רקע, כגון סוכרת, יתר לחץ דם, השמנת יתר, שומנים בדם, מחלת כליות כרונית.
- + תסמינים –
- כאב ראש או הפרעות בראייה.
- כאב בטן (RUQ).
- קוצר נשימה.
- פרכוס.

## 2 דגשים לבדיקה גופנית

- + שינויים במצב ההכרה.
- + לחץ דם –
- סיסטולי < 140 mmHg או דיאסטולי < 90 mmHg.
- + בצקת גומתית בשוקיים או בקרסוליים.

## 3 חמצן

תן חמצן במסכה בקצב של 10 L/min.

## 4 דורמיקום

רק במקרה של פרכוס מתמשך מעל 3 דקות – תן דורמיקום  $1.V / 1.M / 1.N$ .

## 5 מגנזיום סולפט

תן מגנזיום סולפט תוך־ורידי בהזלפה איטית לטיפול באקלמפסיה כמפורט בעמוד הבא.

## 6 לבטול

תן לבטול תוך־ורידי לטיפול ביתר לחץ דם –  
סיסטולי מעל 160 mmHg או דיאסטולי מעל 110 mmHg.

תוכן עניינים > כללי : פרק 6

**טיפול תרופתי****לבטלול**

- + מנגנון פעולה** – חסימת רצפטורים אדרנרגיים מסוג אלפא וביתא. גורם להרחבה של כלי דם עורקיים (וזודילטציה), להאטה בדופק ולירידה בתפוקת הלב.
- + מינון וצורת מתן התרופה** – בולוסים חוזרים בהזרקה תוך־ורידית במינון של 20 mg בכל 5-10 דקות. מינון מקסימלי מצטבר **לא יעלה** על 300 mg. יש למדוד דופק ולחץ דם טרם מתן כל בולוס.
- + התוויות למתן התרופה** – לחץ דם סיסטולי מעל 160 mmHg או דיאסטולי מעל 110 mmHg, אצל מטופלת עם חשד לפרה־אקלמפסיה או אקלמפסיה.
- + התוויות נגד מתן התרופה** –
  - אלרגיה ידועה לחוסמי אלפא או ביתא.
  - ברדיקרדיה מתחת ל־60 פעימות בדקה.
  - חסם עלייתי־חדרי מדרגה 2 ומעלה.
  - היסטוריה של אסתמה קשה.

**מגנזיום סולפט**

- + מנגנון פעולה** – הרפיית שריר חלק. גורם להרחבה של כלי דם עורקיים (וזודילטציה).
- + מינון וצורת מתן התרופה** – הזלפה תוך־ורידית במינון 4 gr במשך 10 דקות. יש למהול ב־100 ml תמיסת סליין.
- + התוויות למתן התרופה** – חשד לרעלת היריון, בעקבות אחד מאלה –
  - פרכוס נצפה.
  - מטופלת לאחר פרכוס.
  - שינויים במצב ההכרה במטופלת עם רקע של פרה־אקלמפסיה.
- + דגשים לטיפול** –
  - יש לנטר לחץ דם, דופק ונשימה בכל זמן הטיפול והפינוי.
  - יש להפסיק את הטיפול אם לחץ הדם הסיסטולי יורד ביותר מ־30 mmHg ביחס לערך הבסיסי.
  - אם מתפתח דיכוי נשימתי או מופיעות הפרעות בקצב או בהולכה – יש להפסיק מייד את הטיפול ולשקול מתן קלציום גלוקונאט (1 gr תוך־ורידית בהזלפה במשך 5 דקות), לאחר התייעצות עם הרופא במוקד הרפואי.

דורמיקום

- + **מנגנון פעולה** – דיכוי הפעילות המוחית באמצעות חיזוק פעילות הנוירטרנסמיטר GABA.
- + **מינון וצורת מתן התרופה** – (בפרכוס על רקע אקלמפסיה) **מנה חד־פעמית** –
  - ב־I.V – 5 mg
  - ב־I.M / I.N – 10 mg
- + **אינדיקציות למתן התרופה** – פרכוס נצפה אצל מטופלת עם חשד לאקלמפסיה.
- + **דגשים** –
  - יש לנטר לחץ דם, דופק ונשימה בכל זמן הטיפול והפינוי.
  - אם לחץ הדם יורד יש לתת עירוי סליין.